

末梢神経症状(CIPN):薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

1 末梢神経障害の薬薬連携 — しびれを同じ物差しで追う

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 累積投与量の管理と減量・休薬基準の確認	累積投与量 (オキサリプラチン等)	① 具体的な動作でしびれを聞き取り、経時的に記録
② 投与前のしびれの評価と処方医への提案	しびれの程度 (同じ質問で比較)	② 転倒・やけど・靴ずれの予防を生活に即して指導
③ オキサリプラチンの急性症状・過敏症への院内対応	対症療法の効果 (眠気・ふらつき)	③ デュロキシセチン等の効果と眠気・ふらつきの確認
④ 計画的な休薬や皮下投与など投与法の提案	生活上の支障 (転倒・やけど)	④ 他院処方(抗真菌薬・抗うつ薬等)の相互作用確認
⑤ 減量・休薬の結果を薬局へ伝達		⑤ 運転・仕事・家事への支障を具体的に聴取

2 予防と対症療法 — エビデンスの整理

減量・休薬・投与法の工夫	デュロキシセチン	プレガバリン・ミロガバリン
対象・方法 オキサリプラチンの計画的な休薬、ボルテゾミブの皮下投与など 位置づけ 最も確実な対策 薬剤師の確認ポイント 症状の推移を処方医へ伝える	対象・方法 痛みを伴うCIPN 位置づけ 有効性が示され、ガイドラインで推奨 薬剤師の確認ポイント 国内ではCIPNは適応外。悪心・眠気、併用薬によるセロトニン症候群	対象・方法 神経障害性疼痛 位置づけ CIPNへの有効性は限定的 薬剤師の確認ポイント 眠気・ふらつきによる転倒、腎機能に応じた用量
冷却・圧迫療法	牛車腎気丸・ビタミンB12	
対象・方法 タキサンの投与中に手足を冷却・圧迫 位置づけ 予防効果の報告あり(施設の方針による) 薬剤師の確認ポイント 冷えの不快感・凍傷	対象・方法 慣習的に使われることがある 位置づけ 予防・治療効果は確立していない 薬剤師の確認ポイント 効果を確認し、継続の要否を処方医と相談	

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
注意 添付文書 併用注意	ピンクリスチン・ボルテゾミブ等 CYP3A4阻害	処方薬 アゾール系抗真菌薬・クラリスロマイシン	血中濃度↑ → 神経障害↑	他院の抗真菌薬・抗菌薬を確認
注意 添付文書 併用注意	デュロキシセチン セロトニン作用の重複	処方薬 SSRI・トラマドール・トリプタン系	セロトニン症候群	他院の抗うつ薬・鎮痛薬を確認
注意 添付文書 併用注意	デュロキシセチン CYP1A2阻害	処方薬 フルボキサミン・シプロフロキサシン	血中濃度↑ → 悪心・眠気↑	他院の抗うつ薬・抗菌薬を確認
注意 添付文書 併用注意	プレガバリン・ミロガバリン 中枢抑制の重複	処方薬 生活習慣 オピオイド・睡眠薬・飲酒	眠気・ふらつき → 転倒	腎機能に応じた用量と転倒リスクを確認
確認 服薬指導上の注意	オキサリプラチン 寒冷刺激で誘発	生活習慣 冷たい飲食物・冷気	手足・のどのしびれ	投与後数日は常温の飲み物、手袋・マフラーを

4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

① 治療開始前	② 投与後～数日	③ 数コース後	④ 治療終了後
“しびれは薬の量が増えるにつれて出やすくなります。ボタンかけや字を書く時の変化を教えてください” ✓ 薬局で確認 お薬手帳でレジメン、糖尿病・アルコール多飲など神経障害の既往 △ ここに注意 しびれは我慢せず伝えるよう説明	“冷たい物に触れたり飲んだりすると、手足やのどがしびれることがあります”(オキサリプラチン) ✓ 薬局で確認 急性症状の有無、冷たい飲食や外気への対策 △ ここに注意 息苦しさに発疹・血圧低下を伴えば過敏症を疑い連絡	“前回と比べて、しびれで困る動作は増えましたか。箸やボタン、歩く時はいかがですか” ✓ 薬局で確認 同じ質問で経時比較、転倒・やけどの有無、鎮痛薬の効果と副作用 △ ここに注意 生活への支障(Grade2以上)は処方医へ情報提供	“治療が終わってしばらくは、しびれが強くなることもあります。続く時は教えてください” ✓ 薬局で確認 中止後の悪化、運転・仕事への影響、対症療法の継続の要否 △ ここに注意 長く残る症状は処方医と継続して共有